



2

ARTRITIS

Dr. Leonardo De Lillo

Jefe de Sala de Internación, CEM 5, Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. CABA.

Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos,
Hospital Municipal de Pediatría Federico Falcón. Pilar.

Médico Pediatra con Capacidades Agregadas en
Medicina Interna (SAP).

Especialista en Terapia Intensiva, Neumonología y
Emergentología Pediátrica (SAP-UBA-Colegio Médico V).

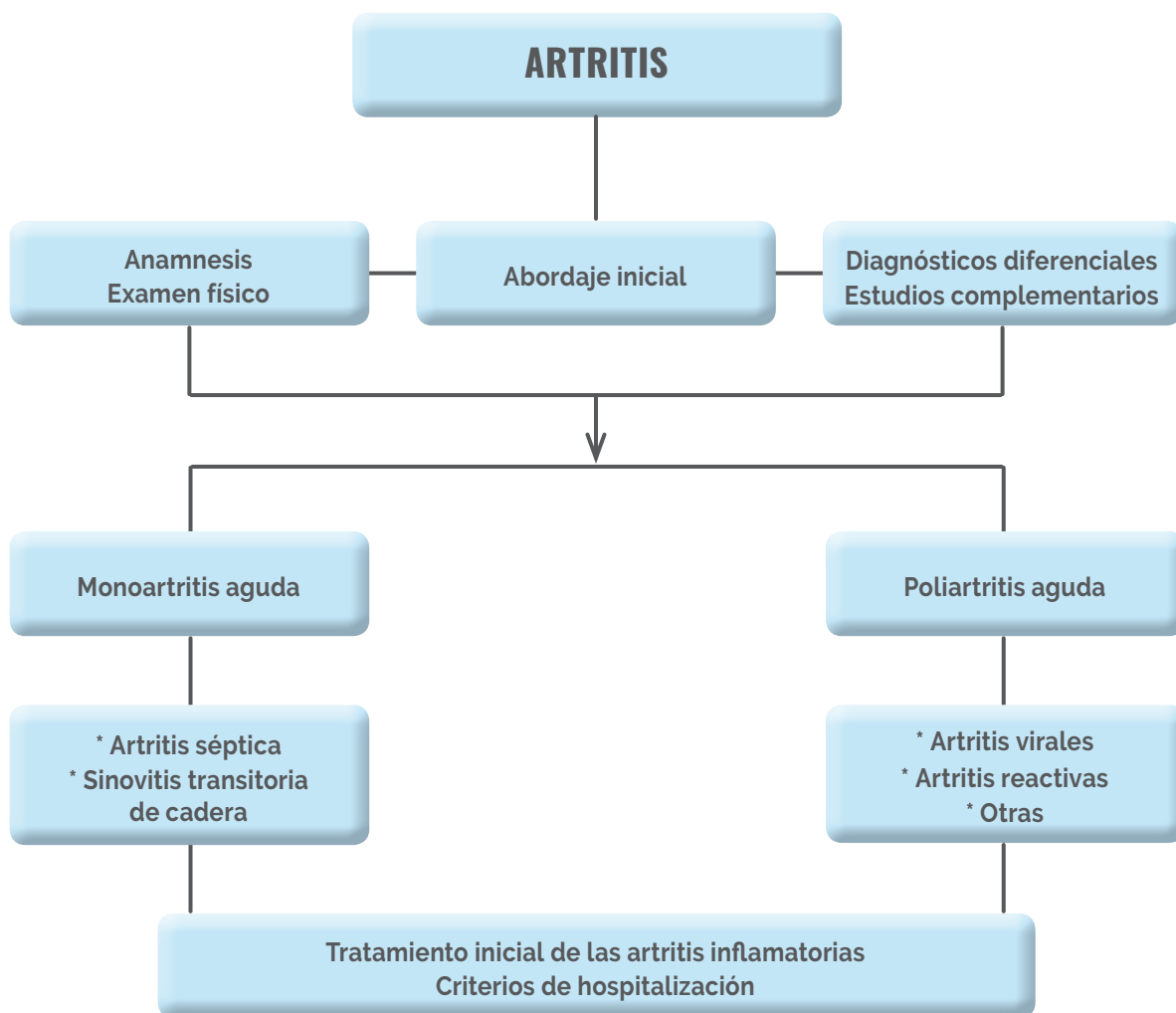
Diplomado en Seguridad del Paciente. Universidad
Austral.

Consultor del Comité Nacional de Medicina Interna
Pediátrica (2019-2021).

Objetivos

- ✦ Advertir la existencia de inflamación articular a partir de la anamnesis, del examen físico general y del examen articular en particular.
- ✦ Sospechar las principales etiologías de artritis basándose en las manifestaciones clínicas y la edad del niño.
- ✦ Recordar que la artritis séptica es una urgencia y que el tiempo que demora la iniciación del tratamiento antibiótico modifica el pronóstico.
- ✦ Diferenciar claramente la artritis séptica de la sinovitis transitoria de cadera.
- ✦ Indicar la extracción de muestras de sangre y de líquido sinovial para enviarlas a cultivo antes de iniciar antibioticoterapia.
- ✦ Prescribir AINES para calmar el dolor.
- ✦ Plantear diagnósticos diferenciales teniendo presente que una afección monoarticular puede ser secundaria a un proceso local pero que también puede ser expresión de una enfermedad sistémica.
- ✦ Plantear diagnósticos diferenciales teniendo presente que una poliartritis aguda puede ser la presentación inicial de algunas enfermedades oncohematológicas.
- ✦ Decidir qué estudios se deben solicitar según se trate de una monoartritis aguda o de una poliartritis aguda.
- ✦ Indicar siempre una artrocentesis diagnóstica ante una monoartritis.
- ✦ Decidir la interconsulta oportuna con los especialistas.

Esquema de Contenidos



Glosario

AIJ	Artritis idiopática juvenil
AS	Artritis séptica
DMJ	Dermatomiositis juvenil
EASN	Espondiloartropatías seronegativas
EBHGA	Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo A
EII	Enfermedad inflamatoria intestinal
ER	Enfermedad reumática
ETC	Enfermedades del tejido conectivo
FR	Fiebre reumática
IOA	Infecciones osteoarticulares
LES	Lupus eritematoso sistémico
PAMO	Función aspirativa de médula ósea
PSH	Púrpura de Schönlein Henoch
SAMR	<i>Staphylococcus aureus</i> meticilino resistente
STC	Sinovitis transitoria de cadera

Introducción

La artritis constituye un frecuente motivo de consulta en pediatría, tanto en consultorio como en el servicio de urgencias, que requiere un abordaje temprano para detectar las causas que necesitan una intervención urgente.

Los datos epidemiológicos sobre artritis aguda son muy escasos y variables. Según bibliografía extranjera, la incidencia de cualquier forma de artritis en niños menores de 16 años ronda alrededor de 100/10.0000.

La mayoría de las artritis son temporales y la cadera es la articulación más frecuentemente comprometida debido a una sinovitis transitoria. En orden de frecuencia siguen la artritis séptica y las reactivas.

El diagnóstico diferencial es muy amplio, las causas son múltiples y de variado origen: infeccioso, inflamatorio, inmunológico, traumatológico, infiltrativo y/o metabólico, lo que determina distintas indicaciones de manejo.

En el caso particular de las enfermedades reumáticas pueden pasar meses hasta llegar al diagnóstico final, lo que dificulta aún más el trabajo del clínico pediatra. Se puede estar ante una sinovitis transitoria de cadera (STC) que se maneja en forma ambulatoria y sólo requiere reposo y antiinflamatorios, o puede tratarse de un caso más grave que necesita de un tratamiento de urgencia como, por ejemplo, la artritis séptica (AS). Entre estos dos extremos se encuentran otras artritis que pueden acompañar a signos o síntomas de diversas enfermedades que requieren de estudios más profundos e incluso internación para llegar a definir el diagnóstico y realizar un adecuado tratamiento.

La anamnesis y la exploración física detallada, en la mayoría de los casos, son las principales herramientas que ayudan a arribar a una sospecha sobre la causa de la artritis, a plantear diagnósticos diferenciales y a orientar los exámenes complementarios adecuados evitando solicitar estudios innecesarios.

La artritis puede ser la única manifestación de la enfermedad, ser la característica predominante o puede, en algunas ocasiones, pasar inadvertida por su escasa repercusión clínica. Otras veces puede ser expresión de una enfermedad sistémica.

Ante un niño que consulta por artritis, el médico pediatra debe estar capacitado para examinarlo adecuadamente, saber que estudios solicitar, detectar las formas que requieren de un tratamiento urgente o las que son potencialmente graves para efectuar una derivación oportuna.

Definición. La artritis se define como la presencia de inflamación de una articulación manifestada por dolor a la palpación y/o a la movilización, tumefacción y limitación de la movilidad.

Hay que diferenciarla de la artralgia que presenta sólo dolor, sin tumefacción ni limitación del movimiento (sin otros signos inflamatorios).

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

ANAMNESIS

La información será aportada por los padres y, si es posible, por el niño preguntándole con lenguaje adecuado a su edad. Una anamnesis completa permitirá recolectar datos clave, descartar algunas causas y orientará sobre cómo seguir.

📌 Antecedentes personales

Sobre el periodo perinatal, desarrollo y maduración, alimentación, vacunación, enfermedades previas de manejo ambulatorio o que han requerido internación, antecedentes quirúrgicos, entre otros. También se ha de indagar sobre antecedentes patológicos que pudieran estar relacionados al motivo de consulta tales como procesos infecciosos agudos o crónicos, presencia de trastornos de la coagulación, de artritis idiopática juvenil (AIJ) o inmunodeficiencia.

📌 Enfermedad actual, la artritis.

a) **Forma de comienzo:** aguda, de comienzo brusco con síntomas inflamatorios intensos o insidiosa de instalación más gradual con fluctuación de los signos y síntomas.

b) **Tiempo de evolución:** orienta la sospecha diagnóstica según se trate de una artritis **aguda** (evolución menor a 6 semanas) o **crónica** (evolución mayor a 6 semanas). Se debe tener en cuenta que, en casos de niños pequeños, con frecuencia los padres no han advertido grados leves de inflamación articular por largos periodos de tiempo.

c) ¿Tiene compromiso de una o más articulaciones?

El cuadro clínico del niño que consulta por artritis, puede ser inicialmente clasificado de acuerdo al número de articulaciones comprometidas.

- **Monoartritis:** inflamación de una sola articulación.
- **Oligoartritis:** hasta un máximo de 4 articulaciones comprometidas.
- **Poliartritis:** con 5 o más articulaciones afectadas.

Si existe compromiso de varias articulaciones hay que conocer la cronología del compromiso articular, siendo muy importante obtener una descripción precisa de lo que es llamado patrón de aparición temporal o patrón articular. La afectación de varias articulaciones puede darse en distintas formas.

- **Aditiva:** a una primera localización con artritis se van sumando otras sin mejorar las anteriores, como ocurre en la AIJ o leucosis.
- **Migratriz o saltatoria:** a medida que se afectan unas articulaciones se resuelve el compromiso inflamatorio en otras localizaciones, por ejemplo en la fiebre reumática (FR).
- **Simultánea:** compromiso de varias articulaciones como ocurre en las artritis virales.
- **Autolimitada o remitente:** como en la STC, FR o artritis reactivas.

- d) Características de la artritis:** en general las de etiología infecciosa (viral o bacteriana) son más dolorosas y las formas inflamatorias crónicas son menos dolorosas. Puede tener una evolución progresiva, aumentando la inflamación con el paso del tiempo o no.
- e) Relación con el ejercicio físico y el reposo:** las artritis de etiología inflamatoria crónica el dolor no es tan llamativo, es típica la rigidez matutina, que constituye un dato cardinal (entumecimiento tras el reposo) y mejoría con la actividad.
- f) Episodios previos de similares características:** episodios anteriores de cojera orientan, por ejemplo, hacia una posible enfermedad de Perthes.
- g) Tratamientos recibidos:** indicados por profesionales o adoptados por los padres: interrogar si con ellos algún signo o síntoma se ha modificado o desaparecido.
- h) Actividades de la vida diaria:** explorar en comparación con niños de su edad: tipos de juegos, actitud para vestirse, actividad en la escuela, clases de educación física, deportes que realiza, desempeño y otras actividades.
- i) Presencia o no de manifestaciones generales acompañantes:** referencia de fiebre, anorexia, pérdida de peso, rash, úlceras bucales, dolor abdominal, alteraciones en el ritmo evacuatorio, disfagia y otras que pueden orientar a determinadas patologías.
- j) Evolución de la enfermedad actual:** es importante conocer todos los detalles posibles, desde el comienzo hasta el momento actual, para poder plantear diagnósticos diferenciales.

Antecedentes de la enfermedad actual

Identificar, a través del interrogatorio, los elementos desencadenantes o circunstancias que precedieron al debut. Los **procesos infecciosos** (previos o concurrentes) del sistema respiratorio, digestivo u otro, sugieren STC o artritis postinfecciosa. El antecedente de un **traumatismo directo** orientará hacia una fractura o artritis traumática, aunque algunas veces la caída es la consecuencia de una artritis previa no diagnosticada y no la causa. Es de importancia el antecedente de **vacunaciones** y la existencia de un **impacto emocional** reciente.

Antecedentes familiares

Es importante indagar acerca de la existencia de enfermedades autoinmunes entre los familiares cercanos. Frecuentemente se encuentran casos de tiroiditis o vitiligo; se debe preguntar específicamente por psoriasis, lupus eritematoso sistémico (LES), enfermedades asociadas al HLA-B27 como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o espondiloartropatías seronegativas (EASN). Estas son patologías que aluden a una potencial enfermedad reumática (ER).

EXAMEN FÍSICO

Todo niño con artritis debe ser examinado minuciosamente. La exploración física, junto a la información recogida en la anamnesis, orientará hacia el diagnóstico etiológico.



Un examen físico completo comprende la observación de la marcha y la actitud espontánea del paciente, el examen general y el musculoesquelético, incluyendo todas las articulaciones.

a) Observación: del niño en la sala de espera o al ingresar al consultorio permite evaluar la **actitud general** y **capacidad funcional**. Es imprescindible permitirle, si puede hacerlo, deambular y moverse mientras se conversa con los padres sobre el motivo de consulta y antecedentes de su enfermedad.

El cuadro clínico inicial puede ser poco específico, especialmente en lactantes y niños pequeños, siendo el dato más característico el dolor, con postura antiálgica, rechazo de la movilización o impotencia funcional. Es habitual que las articulaciones inflamadas se coloquen espontáneamente en posición antiálgica como un mecanismo de protección frente al dolor o se manifieste con cojera si intentan deambular con un compromiso de alguna articulación del miembro inferior.

b) Examen físico general completo: está dirigido a la detección de otras manifestaciones **extraarticulares asociadas** a la artritis que podrían orientar al diagnóstico. Algunos signos clínicos acompañantes, no detectados por la familia, pueden sugerir determinadas enfermedades inflamatorias, infecciosas o tumorales, que generalmente afectan varias articulaciones.

- Un rash en alas de mariposa puede asociarse al LES y si es eritemato-violáceo se asocia a la dermatomiositis juvenil (DMJ). La aparición de un exantema purpúrico en los miembros inferiores en un niño afebril orientará hacia una púrpura de Schönlein Henoch (PSH).
- La queratodermia palmo plantar y la balanitis circinada se asocian con la enfermedad de Reiter.
- Las úlceras mucosas se observan en LES, Reiter o Behcet.
- La presencia de psoriasis puede determinar el diagnóstico de artritis psoriásica.
- Nódulos subcutáneos pueden encontrarse en la FR y la alopecia en el LES.
- Uñas con hiperqueratosis, puntillado o paroniquia pueden orientar hacia Reiter o Psoriasis.
- La conjuntivitis en Reiter y la queratitis en Sjögren.
- La presencia de uretritis permite sospechar enfermedad de Reiter.

Si un niño presenta, junto con la artritis, fiebre, exantemas, adenopatías y visceromegalias, podría tener una infección viral o, menos frecuentemente, una neoplasia.

Ante un paciente con hematomas de características atípicas o en lugares poco habituales se podría sospechar trastornos de la coagulación o maltrato.

c) Examen articular en particular: en un niño con artritis, el examen clínico general debe continuar con la exploración particular de **todas** las articulaciones, buscando compromiso de otras.

Idealmente debemos conseguir tranquilizar al niño, lograr su confianza para que coopere y se relaje.

Siempre hay que observar la marcha y ciertas maniobras (salto, cuclillas, andar de puntillas o talones) ayudan a localizar la región afectada cuando esta no es evidente.

Se examinan todas las articulaciones de forma sistemática, dejando para el final las inflamadas.

En el examen articular es importante evaluar varios aspectos: la movilidad activa y pasiva, la presencia de tumefacción, dolor y/o limitación de la movilidad. Es útil comparar con la extremidad contralateral para apreciar diferencias de tamaño, color y temperatura. Por otro lado, existen signos que orientan a una evolución crónica de la artritis: dismetrías (mayor crecimiento de la extremidad afectada como consecuencia de la mayor vascularización secundaria a la inflamación); hipotrofia de grupos musculares respecto a la extremidad contralateral sana y deformidades.

Inspección

- El color de la piel, el rubor/eritema de la piel supra yacente no es propio de la artritis, sino de afectación de los tejidos blandos peri articulares que pueden simularla.
- El hallazgo de posibles puertas de entrada (picaduras, heridas) orienta a la etiología infecciosa.
- Relieves óseos/musculares, longitud de miembros, posición de reposo y lugar de máximo dolor.

Ante una poliartritis, hay que inspeccionar el tamaño, tipo y simetría de las articulaciones afectadas que pueden orientar a determinados diagnósticos.

- Pequeñas articulaciones interfalángicas distales o proximales: orienta a una AIJ.
- La localización predominante en interfalángicas distales: orienta a psoriasis y AIJ.
- Si la afección de las pequeñas articulaciones de las manos es asimétrica, interrogar sobre psoriasis dado que puede ser una característica de artritis psoriásica
- Columna cervical orienta a AIJ.
- Grandes articulaciones: en general se comprometen en la FR.
- Simetría del compromiso, pensar en AIJ.
- Asimetría en valgo o varo, espondiloartropatías seronegativas (EASN).

Palpación

- Temperatura de la piel sobre la articulación.
- Signo del choque rotuliano (demuestra aumento del líquido intraarticular).
- Sobrecrecimiento óseo.
- Inflamación de partes blandas y sensibilidad a la palpación, sobre todo en zonas de inserciones tendinosas buscando la asociación con entesitis. Cabe aclarar que se llama entesitis al proceso inflamatorio de la entesis que es a la zona de inserción en el hueso de un tendón, músculo o un ligamento.

Evaluación del rango de movimiento

Observar si mueve activamente la articulación, si es adecuado o dubitativo, si el rango de movilidad articular es normal, si compensa la limitación o completa el rango de movimiento pasivamente.

Hay que tener en cuenta que la inflamación de piel y tejidos blandos suprayacentes a una articulación puede dar lugar a movilización dolorosa y simular una artritis (típico de celulitis o urticaria).

Para evaluar el aparato locomotor puede ser útil el uso **pGALS** (*pediatric Gait, Arms, Legs, Spine*), que es una herramienta validada y sencilla que permite explorar el sistema musculoesquelético del niño en forma completa y en pocos minutos.

TABLA 1.

Examen para la detección de signos y síntomas músculo-esqueléticos. pGALS (*pediatric Gait, Arms, Legs, Spine*).

Preguntas

¿Tiene el niño dolor o rigidez? (entumecimiento tras el reposo)

¿Tiene dificultad para vestirse sin ayuda? (si antes lo hacía)

¿Tiene dificultad para subir y bajar escaleras? (si antes lo hacía)

Maniobras de detección	¿Qué valora?
Observar al paciente de pie y acostado	Actitud espontánea. Exantema Dismetría. Tumefacción articular Desviación en valgo/varo. Atrofia muscular. Pies planos
Miembros superiores Mantén las manos extendidas y levantadas delante de ti Pon las manos hacia arriba y cierra las manos en un puño Haz pinza con el índice y el pulgar Toca las yemas de los dedos con el pulgar de la misma mano Mantén juntas las palmas de las manos a la altura de los codos Levanta los brazos estirados todo lo que puedas Pon las manos detrás del cuello Hay dolor al apretar los nudillos	Flexión anterior de hombros Extensión de codos, carpos y dedos Supinación de codos Flexión de las articulaciones de los dedos Destreza manual Extensión de articulaciones de los dedos y los carpos Extensión de codos y muñecas Abducción de hombros Abducción y rotación externa de hombros Flexión de codos Articulaciones metacarpofalángicas

Miembros inferiores

Realizar signo de la tecla en rodillas
Extiende y flexiona las rodillas
Realizar movimientos pasivos de caderas
Realizar movimientos pasivos de tobillos
Tumefacción de rodillas

Flexión y extensión de rodillas
Rotación, abducción y flexión de caderas
Movilidad de articulaciones tibioastragalina y subastragalina

Columna y temporomandibulares

Abre mucho la boca
Mira al techo
Intenta tocar el hombro con la oreja
De pie y con las rodillas extendidas, intenta tocar el suelo

Articulaciones temporomandibulares y desviación a la apertura bucal
Extensión de la columna cervical
Flexión lateral de la columna cervical
Flexión de la columna tóraco-lumbar
Escoliosis

Deambulaci3n

Observar la marcha espontánea
Camina de puntillas

Camina de talones
Cojera o rechazo a la deambulaci3n

Fuente: Foster HE, Jandial S. pGALS – paediatric Gait Arms Legs and Spine: a simple examination of the musculoskeletal system. Ped Rheumatol Online 2013; 11:44.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Luego de ser evaluados los antecedentes de la enfermedad actual, el desarrollo de la misma y una vez realizado el examen físico se pueden plantear y responder algunos interrogantes y definir puntos fundamentales. Éstos permitirán clasificar adecuadamente a la artritis para plantear los posibles diagnósticos diferenciales, para solicitar los estudios adecuados y así confirmar o descartar la sospecha diagnóstica y actuar en consecuencia.

¿La enfermedad está limitada a una sola articulaci3n o a varias articulaciones?

¿Es monoarticular o poliarticular? Por lo general las enfermedades que afectan a una única articulaci3n obedecen a distintas causas de aquellas que ocasionan compromiso poliarticular.

¿La afecci3n es aguda o crónica? Se sabe por el tiempo de evoluci3n.

¿Qué características tiene/n la/las articulaciones afectadas? Clínica, tamaño, patr3n de compromiso articular.

¿Presenta alguna manifestación extra articular? Otros signos o síntomas fuera de la articulación que tal vez no han sido motivo de consulta pero que se han detectado durante la anamnesis y/o el examen físico. Con esta información se puede saber si la artritis es o no un componente más de una enfermedad multisistémica.

Hay que tener muy presente a estas manifestaciones para el diagnóstico diferencial ya que se relacionan en general con formas de poliartritis y esta a su vez es una presentación habitual de las enfermedades reumáticas.

¿Parece ser una forma grave que requiere tratamiento de urgencia o no?

¿Requiere de estudios complementarios simples o complejos?

¿Se puede manejar en forma ambulatoria o es necesaria la hospitalización?

¿Son necesarias interconsultas con especialistas? ¿Corresponde derivar al especialista?

A continuación están listadas las causas más frecuentes de monoartritis y poliartritis agudas; también, si bien no es tema a tratar en este capítulo, están listadas las causas frecuentes de artritis crónica (*Tablas 2, 3 y 4*).

TABLA 2.

Diagnóstico diferencial de monoartritis agudas.

Relacionadas con infección	Artritis séptica. Sinovitis transitoria de cadera. Artritis viral (raro monoarticular). Artritis reactiva (raro monoarticular)
Traumática	Traumatismos articulares, raros en niños <8 años
Trastornos mecánicos	Menisco discoide. Osteocondritis disecante
Sinovitis por cuerpo extraño	Espinas
Inflamatoria	Artritis Idiopática Juvenil de inicio monoarticular Espondiloartropatías seronegativas
Hemartrosis	Discrasias sanguíneas. Hemofilias. Diátesis hemorrágicas por otras coagulopatías

Fuente: modificado de: Murias Loza S, Alcobendas Rueda RM, Udaondo Gascón C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Protoc diagn ter pediatr. 2020;2:17-26. Sociedad Española de Reumatología Pediátrica.

TABLA 3.

Diagnóstico diferencial de monoartritis crónicas.

Relacionadas con infección	Tuberculosis. Micosis. Enfermedad de Lyme
Traumática	Microtraumatismos repetidos (deportistas)
Mecánica	Osteocondritis. Necrosis ósea avascular
Sinovitis por cuerpo extraño	Espina. Sangre
Tumores de la sinovial	Hemangioma. Sarcoma sinovial. Sinovitis vellonodular pigmentaria. Metástasis
Enfermedades inflamatorias	AIJ – EASN

Fuente: modificado de: Murias Loza S, Alcobendas Rueda RM, Udaondo Gascón C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Protoc diagn ter pediatr. 2020;2:17-26. Sociedad Española de Reumatología Pediátrica.

TABLA 4.

Diagnóstico diferencial de poliartritis.

Relacionada con infección	Virales (Parvo B19, rubeola). Sepsis. Fiebre reumática. Artritis séptica (Neonatos e inmunocomprometidos) Endocarditis bacteriana subaguda. Artritis posestreptocócica. Artritis reactiva post disentería. Enfermedad de Reiter. Enfermedad de Lyme (de evolución crónica)
Inflamatoria	Artritis idiopática juvenil. Lupus eritematoso sistémico Dermatomiositis juvenil. EASN. Esclerodermia, EMTC o sind. de Superposición. Enfermedades autoinflamatorias. PSH y Enf. de Kawasaki, otras vasculitis sistémicas. Enfermedad inflamatoria intestinal.
Malignidad	Leucemia. Linfosarcoma. Neuroblastoma
Mecánica	Síndromes hipermovilidad (artritis periódicas). Displasias esqueléticas
Otras enfermedades sistémicas	Enfermedades del suero. Hipersensibilidad a drogas. Fiebre mediterránea familiar. Mucopolisacaridosis y otras enfermedades de depósito.

Fuente: modificado de: Murias Loza S, Alcobendas Rueda RM, Udaondo Gascón C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Protoc diagn ter pediatr. 2020; 2:17-26. Sociedad Española de Reumatología Pediátrica.

RECUERDE

Ante una monoartritis aguda

Asegurarse que sea una y sólo una articulación comprometida: la mayor intensidad del proceso inflamatorio en una sola localización puede llevar a clasificar erróneamente a una enfermedad que es poliarticular como una monoarticular.

Ante la presencia de dolor y tumefacción en una sola articulación recordar siempre, que **el primer diagnóstico a pensar y descartar es una infección (artritis séptica) aunque los síntomas articulares sean mínimos.**

La monoartritis más frecuente es la sinovitis transitoria de cadera (STC) que requiere pocos estudios, poco tratamiento y tiene buen pronóstico.

La artritis séptica es una urgencia infectológica y traumatológica que requiere de un diagnóstico precoz y el inicio urgente del tratamiento apropiado para salvar la articulación.

La artritis idiopática juvenil (AIJ), en la edad pediátrica, debuta como monoartritis en un 50 % de los casos.

En pacientes inmunosuprimidos, ya sea por su enfermedad de base o por el uso de inmunosupresores, **los síntomas de infección pueden estar ausentes.**

La afección monoarticular puede ser secundaria a un proceso local o a veces ser expresión de una enfermedad sistémica.

Con sólo preguntar si hay antecedentes de traumatismo o de alguna discrasia sanguínea se puede descartar dos causas de monoartritis aguda: la traumática y la hemorrágica.

Ante una poliartritis aguda

La inflamación poliarticular es una manifestación común de diversas enfermedades en las que el diagnóstico es fundamentalmente clínico.

La poliartritis es una presentación habitual de las enfermedades reumáticas.

La forma aguda más frecuente es la poliartritis viral y la forma crónica de ER más frecuente es la AIJ.

Se debe buscar, a través del interrogatorio y del examen físico, la presencia de **manifestaciones extraarticulares** asociadas.

Una poliartritis aguda puede ser la presentación inicial de enfermedades oncohematológicas.

Se suelen necesitar estudios complementarios más complejos tales como anticuerpos séricos para bacterias, virus, estudios inmunológicos, punción aspirativa de médula ósea (PAMO) entre otros.

Mayoritariamente se relacionan a enfermedades de evolución crónica.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Se deben solicitar en función del diagnóstico de sospecha que la anamnesis y la exploración física sugieran. Existen algunas patologías que pueden descartarse con un buen interrogatorio y un examen físico cuidadoso como por ejemplo, las de origen traumático, la hemartrosis o la STC.

En el caso de la AS, requiere de una alta sospecha, un buen examen clínico y pocos estudios entre los que no puede faltar la artrocentesis que permite demostrar líquido purulento.

La STC es la única etiología de monoartritis en la que no es necesario realizar análisis de sangre ni de líquido articular, siempre que los datos clínicos apoyen el diagnóstico, así como la radiografía convencional que excluye procesos ortopédicos y la ecografía que demuestra una leve inflamación sinovial.

Los posibles estudios a realizar incluyen:

- ✦ Estudios de laboratorio
- ✦ Radiología convencional
- ✦ Ecografía
- ✦ Estudio del líquido sinovial
- ✦ Estudios microbiológicos e inmunológicos.

En algunas situaciones, se podrían necesitar otros estudios.

a) Estudios de laboratorio

- Hemograma: puede orientar hacia causa infecciosa o inflamatoria, con la presencia de hiperleucocitosis e hiperplaquetosis así como para descartar citopenias asociadas (leucosis).
- Reactantes de fase aguda: es importante valorar la elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR). La PCR se eleva en las primeras 8 horas y se normaliza a la semana, es un marcador de respuesta favorable al tratamiento que resulta muy útil para el seguimiento.
- Estudio básico de coagulación: su alteración orienta hacia una posible hemartrosis secundaria a un cuadro hemorrágico.
- Orina, función hepática y renal.
- Anticuerpos anti-estreptolisina O: se solicitan en caso de sospecha de FR; los títulos elevados revelan el antecedente de una infección reciente por *Streptococo Pyogenes*. Si el paciente reúne criterios de FR, se debe realizar una curva de los mismos (con un intervalo de 2-4 semanas).

Según la sospecha etiológica se valorará de forma individualizada ampliar con estudios inmunológicos, dosaje de Inmunoglobulinas, test de anticuerpos antinucleares (FAN o Anti-DNA, Anti-ENAs), Factor reumatoide y HLAB-27 si hay sospecha de artritis inflamatorias crónicas.

Muchos de ellos pueden estar presentes en niños sanos, sin ser específicos de enfermedad reumática.

b) Radiología convencional

La radiografía simple es importante en un primer nivel diagnóstico para descartar lesiones óseas asociadas a la artritis. Hay que efectuar una placa tanto de la articulación afectada como de la contralateral (par radiológico comparativo) ya que el cotejar permite apreciar la existencia de alteraciones radiológicas mínimas.

En gran parte de los casos sólo ayuda a excluir otras etiologías como los procesos ortopédicos, aplastamiento de cabeza femoral (enfermedad de Perthes o necrosis aséptica) o epifisiolisis. Pueden verse también procesos malignos primarios del hueso mostrando la ubicación, la extensión, ruptura de la cortical, osificación o desosificación, reacción endostal o periostal.

En la AS puede evidenciar en forma indirecta la presencia de derrame con el aumento del espacio articular o la distensión de la cápsula y también mostrar complicaciones óseas como lesiones osteolíticas, si existiese osteomielitis intraarticular asociada.



La radiología toma más importancia en el estudio de las artritis inflamatorias de evolución crónica.

Aunque inicialmente puede ser normal, a medida que la actividad de la enfermedad se va prolongando, las placas seriadas permiten seguir la evolución del compromiso articular manifestando: disminución del espacio articular, erosiones y diferencias en el tamaño epifisiario debido a alteración del crecimiento (acelerado).

c) Ecografía articular

Es una exploración inocua, rápida, económica que puede hacer evaluaciones estáticas, dinámicas y comparativas. Es un recurso no siempre accesible.

Ha demostrado ser el método más sensible para detectar aumento del líquido intraarticular y en pequeñas cantidades, siendo de gran utilidad para evaluar a cualquier articulación en especial la cadera dado que se trata de una articulación profunda.

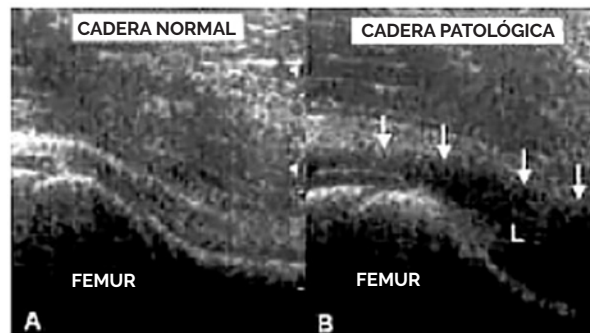
En el estudio de la rodilla permite descartar la presencia de un quiste poplíteo y en todos los casos ayuda a distinguir entre engrosamiento sinovial mínimo y aumento de líquido articular.

Así mismo, en manos expertas, descarta lesiones musculares, establece la existencia de tenosinovitis, roturas tendinosas, colecciones o abscesos periarticulares y posibilita también evaluar la cortical ósea.

La ecogenicidad del líquido puede, en algunas ocasiones, indicar la causa del derrame, las hemorragias y los exudados son generalmente ecogénicos (con detritus), mientras que el trasudado tiende a ser anecogénico-hipoecogénico (limpio). Su mayor inconveniente es ser explorador dependiente.

FIGURA 1.

Ecografía articular cadera normal y cadera patológica.



Fuente: Kreindel T et al. ¿Artritis séptica o sinovitis transitoria? Arch Argent Pediatr 2007;105(4):372-374/372.

La ecografía compara la cadera normal (A) con la contralateral (B) que tiene derrame articular. Se puede ver aumento de espacio articular (L) con contenido anecogénico (negro) con borde convexo anterior (flechas).

FIGURA 2.

Ecografía articular. Ensanchamiento del espacio articular.



Fuente: Kreindel T et al. ¿Artritis séptica o sinovitis transitoria? Arch Argent Pediatr 2007; 105(4):372-374/372.

La ecografía muestra ensanchamiento del espacio articular (flechas) con contenido ecogénico (A) debido al exudado (detritus) en un niño con artritis séptica.

d) Artrocentesis con el estudio del líquido articular

La artrocentesis o punción articular con aguja para obtener líquido sinovial es un pilar fundamental e imprescindible en el estudio de las monoartritis donde es necesario estudiar el líquido articular. Excepto en la STC y otros procesos ortopédicos como ya se ha mencionado.

Es una técnica con escaso riesgo en condiciones de asepsia rigurosa y muy útil, ya que el líquido sinovial puede brindar valiosa información para aproximar el diagnóstico, fundamentalmente permite definir si es una causa infecciosa o inflamatoria marcando la conducta terapéutica a seguir.

Sería ideal que los pediatras estén capacitados para realizarla ya que la presencia de monoartritis aguda, puede convertirse en una emergencia cuando es causada por una infección bacteriana.

Se deben enviar al laboratorio muestras de líquido sinovial para realizar estudios citobioquímicos y microbiológicos.

La artrocentesis tiene un rol **diagnóstico** muy claro, está indicada en la evaluación inicial de una monoartritis y tiene también un **rol terapéutico** ya que permite el drenaje de una AS y de una hemartrosis (corrigiendo antes el trastorno de la coagulación). En el manejo del paciente artrítico crónico (alivia el dolor por drenaje de líquido) y permite Inyectar medicación (corticoides).

Es un procedimiento que casi no tiene contraindicaciones en la práctica clínica habitual, la única contraindicación absoluta sería un severo trastorno de la coagulación. De todas maneras hay que ser cautelosos: ante una infección en piel o tejido subyacente; debe realizarse con extremas medidas de asepsia, bajo campo quirúrgico y uso de material estéril; en niños mayores bajo anestesia local y en los más pequeños (menor de 3 años) se debe evaluar si es necesario realizarla bajo sedación o anestesia general.

TABLA 5.

Características del líquido sinovial.

Líquido	Aspecto	Color	Viscosidad	Leucocitos	Neutrófilos	Glucosa	Cultivo
Normal	Transparente	Claro	Aumentada	<200	<25 %	Normal	Negativo
No inflamatorio	Transparente	Amarillento	Aumentada	200-2.000	<25 %	Normal	Negativo
Inflamatorio	Turbio	Amarillento opalescente	Disminuida	2.000 a 100.000	>55 %	Disminuida	Negativo
Séptico	Purulento	Amarillo verdoso	Variable	>100000	>75 %	Muy disminuida	Positivo
Traumático Coagulopatía	Hemático	Rojizo	Variable	<2.000	-	Normal	Normal

Las características orientan a ciertos diagnósticos, por ejemplo: ante un **líquido no inflamatorio** hay que descartar patología mecánica como traumatismos y osteocondritis, entre otros.

Si el líquido es **inflamatorio** orienta a descartar enfermedades reumáticas como AIJ y EASN.

Un **líquido hemático** puede corresponder a una punción traumática, trastornos de la coagulación o enfermedades sinoviales, como la sinovitis vello nodular o hemangioma sinovial.

Si la muestra fuese insuficiente, se debería priorizar según la sospecha, siendo fundamental en el caso de la AS el envío de tubo estéril sin anticoagulante para Gram y cultivos.

e) Estudios microbiológicos

- **Ante la posibilidad de existencia de AS, antes de iniciar antibioticoterapia se deben realizar la extracción del líquido sinovial y la toma de una muestra de sangre para enviarlas a cultivo.**

Las muestras de líquido sinovial y de sangre deben sembrarse en los medios habituales y en los específicos para gérmenes de crecimiento lento (micobacterias).

Se puede realizar Gram y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) siendo esta última muy útil para diagnosticar la infección por el patógeno emergente *Kingella kingae*, de difícil aislamiento debido a su lento crecimiento. Por otra parte, la enfermedad de Lyme y la brucelosis son entidades poco prevalentes en nuestro medio, cuando se sospechan se deben solicitar los estudios correspondientes.

Las serologías de virales a menudo son útiles en el diagnóstico de la artritis virales.

*En el estudio de artritis postinfecciosas es útil la búsqueda de *Streptococo pyogenes* en hisopado faríngeo* (artritis postestreptocócica) y también se debe tomar **el coprocultivo** (artritis reactivas), aunque suelen manifestarse cuando la diarrea ya ha cedido.

La **prueba tuberculínica**, o las recientemente desarrolladas técnicas **IGRA** (*interferón gamma release assays*) juegan su papel en el diagnóstico de ciertas artritis persistentes.

f) Biopsia sinovial

Es posible que no se logre aislar el germen en el cultivo del líquido sinovial pero sí del tejido. También la toma de biopsia, puede ser especialmente útil ante una monoartritis crónica cuando con los estudios anteriores no se llegó a un diagnóstico.

Se realiza a cielo abierto o mediante artroscopia, para obtener tejido sinovial para su estudio histológico y bacteriológico (cultivo para gérmenes comunes, bacilo de Koch y hongos).

A modo de ejemplo, en la AIJ el informe histopatológico arrojaría sinovitis crónica inespecífica.

g) Resonancia magnética (RNM)

Se trata de una práctica útil en el estudio de monoartritis, principalmente en aquellos casos con evolución desfavorable. Su uso es limitado por su alto costo y por la frecuente necesidad de anestesia general.

h) Tomografía computada (TC)

La TC emite una radiación excesiva, pero en muchos lugares se cuenta con ella. Junto a la RNM son de utilidad para completar la evaluación de partes blandas.

i) Centellograma óseo con tecnecio 99

Es poco rentable en el diagnóstico de artritis, salvo en situaciones como la sacroileitis. Se trata de una técnica con la que es posible evaluar el esqueleto completo de alta sensibilidad y baja especificidad para la localización de osteomielitis, fracturas, tumores o metástasis ósea.

Es de destacar que tanto la RNM como la TC y el centellograma **no son utilizados rutinariamente** para la evaluación inicial de una artritis aguda.

Otros estudios e interconsultas

Dependiendo de la sospecha que se tenga como causa de artritis según los hallazgos en el examen clínico y de los estudios iniciales, será necesario profundizar y solicitar otras pruebas complementarias más específicas y dirigidas a buscar alteraciones que orienten hacia otras enfermedades en las que la artritis sería un componente más. Por ejemplo, la ecografía abdomino-renal, ecocardiograma, lámpara de hendidura, PAMO entre otros. El hallazgo de uveitis crónica orienta hacia ARJ; el compromiso renal se ve en LES, PSH y otras vasculitis; el compromiso cardíaco con pericarditis, miocarditis o endocarditis en LES y FR; la pleuritis y neumonitis se ven en LES, Churg Strauss.

En algunas oportunidades será necesario solicitar interconsultas con diversas especialidades.

FORMAS MAS FRECUENTES DE MONOARTRITIS AGUDAS

Se presentan dos entidades importantes que difieren ampliamente en la gravedad, en la metodología diagnóstica, tratamiento y pronóstico.

• ARTRITIS DE ETIOLOGÍA BACTERIANA O SÉPTICA

Es una infección grave y poco común, estimándose su incidencia en alrededor de 5/100.000 niños al año, significa un 6 % de todas las artritis infantiles. Aunque puede darse a cualquier edad, es más frecuente en los menores de 3 años.

Se trata de una artritis debida a la invasión del espacio articular por un germen viable, siendo el implicado con mayor frecuencia y para cualquier grupo etario el *Staphylococcus aureus*.

En menores de 2 años de edad debe considerarse a la *Kingella kingae* especialmente; la familia de los estreptococos es responsable de un pequeño porcentaje (Tabla 6).

A partir del uso universal de vacunas conjugadas en menores de 2 años y del aumento de la incidencia de infecciones por *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (SAMR) adquirido en la comunidad, se reporta mundialmente un cambio en la epidemiología de las infecciones osteoarticulares (IOA) como ha ocurrido también en Argentina en las últimas décadas.

En el 50-80% de los casos se documenta el germen implicado y los hemocultivos son positivos en el 60% de los cuadros agudos.

La artritis tuberculosa o la debida a hongos suelen tener una evolución crónica, son infrecuentes pero deben considerarse en el diagnóstico diferencial.

TABLA 6.
Etiología de las artritis bacterianas según edad.

Edad	Gérmenes
Recién nacido a 2 meses	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> Bacilos Gram negativos (<i>E. coli</i>) Cándidas
2 meses a 5 años	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus pneumonia</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Kingella kingae</i>
Mayor de 5 años	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i>
Adolescentes	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>

Fuente: modificada de Gutierrez K. Bone and joint infections in children. *Pediatr Clin North Am.* 2005 Jun;52(3):779-94.

Forma de presentación. La más frecuente es como monoartritis aguda, aunque se reporta compromiso de más de una articulación hasta en un 22 % de los casos, siendo prácticamente exclusiva de inmunodeficientes y neonatos.

Las grandes articulaciones se encuentran comprometidas con mayor frecuencia que las pequeñas, siendo más frecuente la rodilla y cadera seguidas por el tobillo, codo, hombro y muñecas.

Mecanismo patogénico. En la mayoría de los casos es la vía de diseminación hematógena, sobre todo en los niños pequeños. Menos frecuentemente puede darse también por contigüidad desde una infección cercana (tejidos blandos adyacentes) o por inoculación directa a través de un traumatismo abierto o cirugía.

Clínica. La típica es la de un lactante o niño pequeño, que comienza con fiebre, regular estado general o de aspecto séptico, con dolor intenso e impotencia funcional. Puede presentar tumefacción, eritema, temperatura local aumentada y sensibilidad a la palpación. La extremidad queda fijada en la posición en que el dolor causado por la presión de la cápsula articular es menor. Así la cadera estará flexionada en abducción y rotación externa, mientras que la rodilla y el tobillo estarán flexionados. Si se afecta la cadera, la rodilla o el tobillo producirán cojera.

Algunas veces, **la única manifestación puede ser dolor** al mover al niño durante el cambio del pañal o bien la negativa a mover la extremidad espontáneamente o ante la solicitud, por lo que el paciente parece sufrir una parálisis (pseudoparálisis).

- **La AS debe ser tratada con precocidad, es una emergencia médica que requiere la rápida instauración de tratamiento**
- **antibiótico y en algunos casos drenaje quirúrgico.**

Exámenes complementarios. Es necesario tener un alto índice de sospecha de esta entidad para realizar una artrocentesis de forma temprana, es el procedimiento de elección ya que es diagnóstica y terapéutica, no debe ser retardada por la realización de otros estudios.

Es frecuente la leucocitosis y la elevación de los reactantes de fase aguda.

El examen **radiológico** inicial es inespecífico, pudiendo ser normal o mostrar signos indirectos de derrame articular, evidenciado por aumento del espacio articular o desplazamiento lateral de la cabeza femoral. En la AS complicada puede observarse osteólisis o reacción perióstica y como secuela puede hallarse dislocación de la cadera por destrucción de la cabeza y del cuello femoral.

La **ecografía** es un método de gran ayuda, siendo el más sensible para detectar líquido y engrosamientos sinoviales mínimos. El margen de la cápsula articular aparece convexo, en lugar de cóncavo y su espesor excede los 5 mm; posibilita también la comparación con la otra cadera y diferencia claramente la AS de los abscesos de tejidos blandos o tenosinovitis (*Figuras 1 y 2*).

El **centellograma**, se indica en pocos casos y es útil para evaluar lesiones multifocales u osteomielitis.

En algunas situaciones la **RNM** y la **TC** se indican en casos de difícil resolución ya que localizan muy bien la lesión y permiten identificar complicaciones como osteomielitis, abscesos y destrucción ósea.

Tratamiento. Luego de las tomas de los cultivos correspondientes, debe iniciarse el tratamiento antibiótico empírico precoz por vía intravenosa, según la epidemiología, edad, clínica del paciente y tinción de Gram que luego se adecuará según germen aislado y antibiograma.

TABLA 7.

Antibióticos de elección para el tratamiento empírico inicial según edad.

Edad	Tratamiento empírico inicial
Menor de 3 meses	Ceftriaxone + clindamicina
3 meses a 5 años	Cefotaxime /Ceftriaxone (evaluar vacunación anti HIB) + Clindamicina (sospecha de SAMR)
Mayores a 5 años	Clindamicina

Fuente: modificada de Saavedra-Lozano J, Calvo C, Huguet Carol R, et al. Consensus document on the treatment of uncomplicated acute osteomyelitis and septic arthritis. An Pediatr (Barc). 2015;82(4):273.e1-273.

Se tiene que definir con infectología la vía y duración del tratamiento, y con traumatología la conducta a seguir ya que se debe realizar el drenaje quirúrgico articular precoz del contenido purulento e irrigación con suero salino.

El control evolutivo de las infecciones osteoarticulares (IOA), a través de la clínica y de la PCR, ha permitido el uso de tratamientos secuenciales parenteral/oral eficaces, seguros y de menor duración de acuerdo al agente etiológico rescatado. La articulación comprometida se inmoviliza para disminuir el dolor.

Pronóstico. El principal factor que define el pronóstico de la AS es el tiempo transcurrido hasta el inicio del tratamiento antibiótico.

- **La evolución favorable se asocia al inicio del tratamiento dentro de las 24 horas de aparecidos los síntomas. El empeoramiento del pronóstico es proporcional al retraso en la terapéutica.**

Las posibles **complicaciones** son la osteomielitis y la destrucción del cartílago que puede llevar a una disminución de la funcionalidad o inestabilidad de la articulación. A largo plazo puede verse discrepancia en la longitud de los miembros y discapacidad.

El diagnóstico diferencial de la AS incluye tanto proceso infeccioso como no infecciosos que afectan la articulación (*Tabla 2*).

Si el compromiso es en la cadera, es muy importante poder diferenciar una AS de una STC **ya que ambas son causas de dolor agudo de cadera no traumático**. Aunque pueden presentarse de forma similar y ser clínicamente indistinguibles, hay que tener presente que la STC es mucho más frecuente que la AS de cadera. Ambas tienen una gran diferencia en cuanto al pronóstico y tratamiento.

- **La AS requiere diagnóstico y tratamiento precoz y de ello dependerá la evolución. En cambio, la sinovitis transitoria de cadera generalmente tiene una evolución benigna y su tratamiento es sintomático.**

Las imágenes pueden aportar información que permita su diferenciación pero no son suficientes para decidir realizar la punción articular en un niño con dolor agudo en la cadera. Las imágenes son una herramienta que suma al cuadro clínico y a los datos del laboratorio.

• SINOVITIS TRANSITORIA DE CADERA

Es una artritis inflamatoria idiopática, conocida también como artritis transitoria o sinovitis tóxica. En un servicio de urgencias, esta entidad **representa el motivo más frecuente de consulta por cojera si se excluyen los traumatismos**. La articulación que se afecta con más frecuencia es la cadera. Su etiología es desconocida, si bien en la mayoría de los casos existe un antecedente de infección del tracto respiratorio. Hay que diferenciar la sinovitis transitoria de cadera (STC) de la AS y la enfermedad de Perthes. Esta última se presenta en edades similares, puede debutar con derrame ecográfico y la radiología es clave para su diagnóstico.

Cuadro clínico característico. Es el de un niño, generalmente varón (relación varón: mujer de 2:1) de entre 3 y 9 años que desarrolla de forma brusca dolor en la ingle de intensidad variable, a veces irradiado a la cara interna del muslo y la rodilla ipsilateral, que le provoca cojera antiálgica e incluso rechazo de la deambulación.

El estado general es bueno y el niño no tiene aspecto de enfermo, no se asocia fiebre (salvo infección intercurrente en general respiratoria, que con cierta frecuencia le precede) y no hay otros síntomas musculoesqueléticos.

La actitud espontánea adoptada suele ser de ligera flexión y rotación externa de la cadera. En la exploración se comprueba la limitación dolorosa de la movilidad de la articulación (abducción y rotaciones).

Exámenes complementarios. Las características típicas del cuadro permiten la limitación de las exploraciones complementarias, no siendo necesaria la realización de artrocentesis.

No hay elevación de la VSG ni del recuento de leucocitos.

La radiografía convencional sirve para excluir alteraciones óseas, que se observan en algunas de las patologías consideradas en el diagnóstico diferencial. La ecografía es útil para confirmar el derrame que suele ser muy pequeño (*Figura 1*).

Tratamiento. Es un proceso autolimitado y benigno que se resuelve en pocos días (5 a 10). El tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINES) está indicado para aliviar el dolor, junto con el reposo de la articulación.

FORMAS MÁS FRECUENTES DE POLIARTRITIS AGUDA

Se presentan la artritis vírica, reactiva y otras artritis postinfecciosas. Aunque pueden cursar de forma monoarticular, este grupo de artritis se presenta más frecuentemente como poliartritis.

• ARTRITIS VÍRICA

Es la causa más frecuente de poliartritis en el niño. La invasión de la cápsula articular por un virus es menos frecuente que la etiología bacteriana. Suele coincidir con el curso de algunas virosis siendo los agentes etiológicos habituales el parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela y rubeola.

Su etiopatogenia no está clara, aunque algunas investigaciones han demostrado la presencia del virus en el líquido sinovial.

Clínica. El cuadro típico es el de un niño con poliartrosis, habitualmente dolorosa y simétrica, de instauración más o menos brusca, acompañando a síntomas correspondientes a infección viral como rinorrea, tos, exantema, febrícula o fiebre.

El diagnóstico se realiza mediante la clínica y las serologías.

Exámenes complementarios. El laboratorio, acorde a una infección viral, muestra linfomonocitosis, discreta elevación de transaminasas y de los reactantes de fase aguda.

Tratamiento. En general, su curso es autolimitado, cede en pocas semanas con tratamiento sintomático.

• ARTRITIS REACTIVAS

Aparecen como una reacción secundaria a una infección no localizada en las articulaciones. Se dividen en **Asociadas** al antígeno HLA-B27 que incluyen a las artritis reactivas postdisentéricas y al síndrome de Reiter y en **No asociadas** al antígeno HLA-B27 como son la fiebre reumática y la artritis reactiva postestreptocócica.

a) Artritis reactivas post disentería. Generalmente son secundarias a una infección entérica por gérmenes gram negativos como la *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter* o *Yersinia enterocolitica*. El germen causante no se sitúa dentro de la articulación (está alejado de la articulación) y produce su inflamación a distancia, de forma reactiva y por mecanismos etiopatogénicos no bien esclarecidos, aunque es conocida la asociación con el HLA-B27.

Generalmente se presenta en un varón, mayor de 6 años, con artritis asimétrica de miembros inferiores con entesitis e incluso afectación axial. El proceso es transitorio y el pronóstico final es bueno, sin embargo algunos pacientes pueden tener más tarde una espondiloartropatía crónica.

b) Síndrome o enfermedad de Reiter. Afecta a niños y adolescentes predominante varones y suele precederse de una infección enteral o de un contacto sexual una o dos semanas antes. Dentro de las artritis reactivas es la que tiene el cuadro más definido. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden ocurrir simultáneamente o sucederse en un periodo de 3 a 4 semanas. La forma completa se presenta con la triada de artritis, uretritis aséptica y conjuntivitis, pudiendo asociarse lesiones mucocutáneas características tales como balanitis circinada, úlceras orales y queratodermia. Los gérmenes implicados son la *Shigella*, *Yersinia enterocolitica* y *Chlamydia*. Pueden presentarse además síntomas sistémicos como fiebre, linfadenopatías y esplenomegalia.

El compromiso articular es en general una oligoartritis de miembros inferiores particularmente rodillas y tobillos, asociado a talalgia y entesitis. El dolor en articulaciones sacroilíacas y de la columna es menos frecuente.

La disuria, inflamación del meato y piuria en un sedimento urinario estéril, pueden observarse con más frecuencia que la uretritis que sólo es posible detectarla en un tercio de los niños.

Las lesiones mucocutáneas son menos comunes de encontrar que en adultos.

La enfermedad generalmente puede remitir luego de algunos meses, aunque puede evolucionar por brotes o ir a la cronicidad con compromiso espondilítico.

Los estudios de laboratorio muestran leucocitosis con neutrofilia y VSG acelerada. El urocultivo permite descartar infección, fundamentalmente gonocócica y realizar búsqueda de chlamydia. Los gérmenes enteropatógenos, deberán investigarse mediante coprocultivo y/o titulación de anticuerpos. Un 70 % de los pacientes son HLA-B27 positivos.

c) Fiebre reumática. Su incidencia está disminuyendo en forma constante y notable en los países desarrollados, sin embargo ha sido muy prevalente hasta mediados del siglo XX. La mayor importancia de la enfermedad radica en la posibilidad del compromiso cardíaco.

Se trata de una entidad inmunomediada que aparece 2 o 3 semanas después de una infección faríngea por EBHGA. Surge como complicación de una infección previa no tratada o insuficientemente tratada. Es rara en niños menores de 3 años.

Se caracteriza por lesiones inflamatorias no supurativas. La artritis tiene carácter migratriz, compromete a las grandes articulaciones, genera gran impotencia funcional y suele ser muy dolorosa, tanto que dificulta la semiología. La fiebre es común aunque de naturaleza más bien sostenida que intermitente.

La FR es de curso remitente en un período no mayor a 4 semanas, autolimitada y cura sin secuelas.

La presencia de dos manifestaciones mayores o de una mayor y dos menores indica alta probabilidad de FR aguda.

Criterios de Jones

Manifestaciones mayores	Manifestaciones menores
• Carditis • Poliartritis • Coreo • Eritema marginado • Nódulos subcutáneos.	• Artralgia • Fiebre • Reactantes de fase aguda elevados • Comprobación de la infección por EBHA • Prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma.

d) Artritis reactiva postestreptocócica. Es la artritis, de una o más articulaciones, asociada a infección reciente por EBHGA en un paciente que no cumple criterios de FR. Aparece en los primeros 10 días tras la infección, tiene un período de latencia más corto que el de la FR. El cuadro articular no es como el de la FR, no suele ser migratoria sino persistente o recurrente, compromete las pequeñas articulaciones de las manos. Algunas veces puede ser monoarticular. Puede prolongarse en el tiempo más allá de 4 semanas. La respuesta a AINES es pobre.

• OTRAS CAUSAS IMPORTANTES DE POLIARTRITIS

La poliartritis puede estar presente en el debut o en el curso de diversas enfermedades reumáticas del niño.

Para el diagnóstico diferencial, es preciso tener en cuenta las manifestaciones asociadas. No hay datos de laboratorio ni radiológicos patognomónicos de enfermedad reumática (ER) y estos deben ser interpretados en relación al cuadro clínico. La AIJ es la etiología más frecuente de poliartritis crónica, aunque el LES, la DMJ, las enfermedades autoinflamatorias y la EII, entre otras, presentan compromiso poliarticular.

a) Artritis idiopática juvenil. La AIJ es la enfermedad reumática crónica más frecuente en la infancia. Se define como la artritis de causa desconocida que comienza antes de los 16 años y que persiste más de seis semanas. Se caracteriza por la presencia de rigidez matutina, mientras que el dolor articular no es tan intenso como en otros tipos de artritis. Puede presentarse como monoartritis (en un 50 % de los casos pediátricos) o afectar a más de una articulación. La rodilla es la articulación comprometida con mayor frecuencia. Es una entidad heterogénea, con distintas formas de presentación y evolución hacia la cronicidad. Se distinguen 7 categorías dentro de AIJ según los criterios vigentes de clasificación.

La AIJ de inicio monoarticular u oligoarticular, presenta una alta incidencia de compromiso ocular.

La iridociclitis crónica o uveítis crónica anterior que acompaña a esta enfermedad es a menudo asintomática, pudiendo desarrollar ceguera cuando no es tratada a tiempo. En general el compromiso es bilateral y a veces precede a la aparición de artritis. En ocasiones puede comenzar con ojo rojo, especialmente en varones (>8 años) con mono u oligoartritis crónica y que con el tiempo evolucionan hacia una espondiloartropatía. Por lo tanto es muy importante la búsqueda sistemática de uveítis con lámpara de hendidura, en todo paciente con episodios de monoartritis u oligoartritis crónica.

b) Enfermedades oncohematológicas. Una mención especial merecen las enfermedades oncohematológicas que pueden debutar con compromiso articular. Por ello ante la presencia de niños con artritis o el dolor musculoesquelético inexplicable, acompañado o no de anemia y/o síndrome febril, es fundamental considerar siempre a estas patologías entre los diagnósticos diferenciales.

La artritis secundaria a procesos tumorales, como el neuroblastoma o la leucemia, asienta en más de una articulación y pueden presentar características sistémicas como esplenomegalia y adenopatías.

En el caso de la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el 15 % de los niños puede presentar sinovitis poliarticular de curso aditivo o migratriz y por lo general la intensidad del dolor no suele relacionarse con el grado de tumefacción articular.

La manifestación inicial de la leucemia como artritis es mucho más importante que los tumores óseos primarios.

La presencia de leucopenia, anemia y artritis es motivo de PAMO. Si por las características del dolor se sospechara la posibilidad de una LLA y aunque no se detectaran alteraciones hematológicas en sangre periférica ni por radiología, se debe derivar rápidamente al paciente al hematólogo para realizar una PAMO.

c) Falsas artritis. Por último hay que recordar algunas patologías que simulan ser artritis y pueden prestar a confusión. La reacción urticarial, es una entidad muy frecuente en los niños. Produce tumefacción subcutánea a menudo periarticular y provoca dolor a la movilización de la articulación, por lo que puede interpretarse de forma errónea como artritis.

En la celulitis, ocurre algo muy similar a lo descrito en el caso de urticaria.

Lo mismo sucede con la enfermedad de Osgood-Schlatter, una osteocondrosis del adolescente que cursa con inflamación y dolor en la tuberosidad tibial antero-superior.

Ciertas displasias esqueléticas y los síndromes de amplificación del dolor también se confunden con artritis.

TRATAMIENTO INICIAL DE LAS ARTRITIS INFLAMATORIAS

Puede indicarse la utilización de AINES en forma reglada para aliviar el dolor, la tumefacción o la rigidez matinal. Estos no enmascaran los síntomas de enfermedades graves como neoplasias, infecciones o enfermedades del tejido conectivo (ETC).

AINES para aliviar el dolor

Ibuprofeno	30-40 mg/kg/día (dividido cada 6-8 horas, vía oral. Dosis máxima 1,2 gr/día).
Naproxeno	15-20 mg/kg/día (dividido cada 12 horas, vía oral. Dosis máxima 1 gr/día).

No combinar ambos antiinflamatorios. Mantener a la articulación en posición correcta, en ocasiones mediante una férula de reposo, no es aconsejable inmovilizar con yeso completo, de esta manera se evitan las contracturas en flexión que desarrolla el paciente al buscar una posición antálgica.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN

- Si se sospecha en primera instancia de AS, siempre implica la internación del paciente para realización de los estudios e
- inicio precoz de la terapéutica correspondiente.

Frente a una **monoartritis de evolución crónica**, se valorará la internación de acuerdo al grado de compromiso general. Ante un cuadro de **mono o poliartritis con gran signo sintomatología** como dolor, gran tumefacción con signos de flogosis o compromiso del estado general (sistémico) deberá internarse para completar estudios y tratamiento adecuado.

En determinadas situaciones en las que el paciente inició los síntomas recientemente, sin afectación del estado general, ni otra sintomatología asociada, se podría valorar realizar un seguimiento ambulatorio con tratamiento con AINES por vía oral, indicación de los estudios necesarios y claras pautas de alarma.

¿QUÉ PUEDE HACER EL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA?

- Reconocer mediante la historia clínica y exploración la existencia de inflamación articular.
- Evaluar las principales etiologías de artritis, basándose en las manifestaciones clínicas y la edad del niño.
- Decidir seguimiento ambulatorio, derivar al servicio de urgencias para realizar exámenes complementarios o indicar la hospitalización.
- En todos los casos podrá solicitar las consultas especializadas/derivaciones que crea necesarias ante situaciones tales como problemas ortopédicos o traumáticos, sospecha de hemofilia, sospecha de AIJ u otro trastorno reumatológico y artritis mono o poliarticular persistente.

AUTOEVALUACIÓN 2



Resuelva el siguiente Crucigrama. Las palabras se leen sólo en forma horizontal

								A								
								R								
								T								
								R								
								I								
								T								
								I								
								S								

Referencias.

1. Enfermedad que tiene comienzo súbito y evolución rápida incluyendo su resolución.
2. Inflamación de una sola articulación.
3. Articulación que sólo presenta dolor, sin tumefacción ni limitación de movimiento.
4. Diagnósticos que se plantean para distinguir entre enfermedades que causan síntomas parecidos. Enfermedades que podrían ser la causa de los síntomas que presenta el paciente. Posibles hipótesis que se plantean durante el proceso diagnóstico.
5. Siglas de antiinflamatorios no esteroides.
6. Tipo de artritis que se caracteriza por ir cambiando las articulaciones comprometidas, a medida que se resuelven unas aparecen otras. Por ejemplo: fiebre reumática.
7. Palabra que significa "encender el fuego". Respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños tales como virus y bacterias.
8. Una de las 3 conductas que incluye el examen articular. Las otras dos son palpación y evaluación del rango de movimiento.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 🔹 **Javier**, 15 años. Consulta en la guardia por fiebre y dolor en la rodilla derecha de 48 horas de evolución. Del interrogatorio surge que es un adolescente previamente sano. Al realizar un examen físico detallado se detectan edema e impotencia funcional en rodilla derecha. Además de la artritis de la rodilla se advierte afectación de ambos tobillos. A la inspección se lo ve en regular estado general, posición antálgica, tumefacción articular y puede verse inyección conjuntival. Como antecedentes de la enfermedad actual, refiere que había consultado en la guardia la semana anterior por fiebre, dolor abdominal y disuria; se hizo un sedimento urinario que se interpretó como patológico y le indicaron cefalexina después de una toma de urocultivo que no tuvo desarrollo.

- 1.** ¿En qué piensa como probable etiología? ¿Qué otros datos buscaría?

.....

.....

- 2.** ¿Solicitaría algún estudio complementario? ¿Cuáles?

.....

.....

 Nahuel, 8 años.

Previamente sano, presenta dolor en la rodilla y muslo derecho de 24 horas de evolución que le causa cojera. Se lo ve en buen estado general, afebril, no refiere infecciones ni de trauma recientes. Sin antecedentes familiares ni personales de importancia. El examen físico muestra disminución de la movilidad de la cadera en flexión, aducción y la rotación interna. No hay ninguna otra articulación comprometida.

- 1.** ¿Cuál es su sospecha inicial y qué diagnósticos diferenciales se plantea?

.....

.....

- 2.** ¿Solicita algún examen complementario? De ser así cuáles?

.....

.....

- 3.** ¿Qué conducta tomaría?

.....

.....

Responda las siguientes consignas

- 1.** Establezca las diferencias entre artralgia y artritis.

.....

.....

- 2.** Mencione la clasificación de las artritis según tiempo de evolución y número de articulaciones afectadas.

.....

.....

- 3.** Enumere las características del líquido articular inflamatorio y séptico extraídos por artrocentesis

.....

.....

Conclusiones

Todo niño que presente impotencia funcional requiere pronta atención hasta que se encuentre la causa del problema. Un buen interrogatorio y un examen físico minucioso son fundamentales.

La causa más frecuente de consulta, tanto en consultorio como en la urgencia, es la STC. Es importante diferenciar claramente la AS de la STC. En la AS el tratamiento precoz modifica el pronóstico.

Ante una monoartritis siempre se debe realizar una artrocentesis diagnóstica.

Puede indicarse la utilización de AINES en forma reglada para aliviar el dolor, la tumefacción o la rigidez matinal.

Ante todo paciente con fiebre, rash y artritis se debe descartar infecciones, enfermedades linfoproliferativas, vasculitis (como la PSH o la enfermedad de Kawasaki) y nunca olvidarse de incluir en el diagnóstico diferencial a la AIJ sistémica.

En síntesis: para el manejo inicial de un niño con artritis aguda, es fundamental que el pediatra tenga un gran conocimiento de los **diagnósticos diferenciales** y de la **sistémica de estudio** para poder evaluar la urgencia, los pacientes que deben internarse, los casos que se pueden seguir en forma ambulatoria y los criterios para solicitar los exámenes complementarios complejos o consultas especializadas.

Lecturas recomendadas

- ✿ Murias Loza S, Alcobendas Rueda RM, Udaondo Gascón C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Protoc diagn ter pediatr. 2020;2:17-26. Sociedad Española de Reumatología Pediátrica. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/02_artritis_diagn.pdf
- ✿ Highton E, Pérez MG, Cedillo, Villamagua C, et al. Infecciones osteoarticulares en un hospital pediátrico de alta complejidad: epidemiología y características clínicas asociadas con bacteriemia. Arch Argent Pediatr 2018;116(2):e204-e209.
- ✿ Kathleen A H. The Approach to the Child with Joint Complaints. Pediatr Clin North Am 2018 Aug; 65(4):623-638.
- ✿ de Inocencio Aracena J. Reumatología pediátrica: la importancia de la anamnesis y la exploración. Anales de Pediatría 2016;(84)3:131-132.
- ✿ Devauchelle-Pensec V, Thepaut M, Pecquery R, Houx L. Managing monoarthritis in children. Joint Bone Spine. 2016 Jan;83(1):25-30.

CLAVE 2



Resuelva el siguiente Crucigrama

Las palabras se leen sólo en forma horizontal

								A	G	U	D	A				
			M	O	N	O	A	R	T	R	I	T	I	S		
						A	R	T	R	A	L	G	I	A		
				D	I	F	E	R	E	N	C	I	A	L	E	S
							A	I	N	E	S					
			M	I	G	R	A	T	R	I	Z					
I	N	F	L	A	M	A	C	I	O	N						
						I	N	S	P	E	C	C	I	O	N	

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Javier, 15 años. ARTRITIS REACTIVA

1. ¿En qué piensa como probable etiología? ¿Qué otros datos buscaría?

Teniendo en cuenta que tiene artritis, conjuntivitis y posible uretritis, se puede pensar en una artritis oligoarticular reactiva, con la tríada característica del síndrome de Reiter. Se debe profundizar el interrogatorio buscando otros antecedentes sobre la enfermedad actual como por ejemplo alguna afección intestinal o contacto sexual. En el examen físico buscar compromiso de otras articulaciones y manifestaciones mucocutáneas como ser úlceras orales y queratodermia que pueden verse en el síndrome de Reiter.

2. ¿Solicitaría algún estudio complementario?

Se debe solicitar hemograma en el que se podrán ver leucocitosis con neutrofilia y reactantes de fase aguda que suelen estar acelerados. Hay que realizar estudios microbiológicos incluyendo serologías y cultivos para buscar enteropatógenos y *Chlamydia*.

👉 Nahuel, 8 años. SINOVITIS TRANSITORIA DE CADERA

¿Cuál es su sospecha inicial y qué diagnósticos diferenciales se plantea?

Se trata de un compromiso monoarticular agudo. La patología que se debe descartar en primer lugar es la artritis séptica, por la necesidad de un pronto diagnóstico y su potencial gravedad en el retraso del tratamiento. Dada la presentación clínica y la prevalencia parece tratarse de una STC.

1. ¿Solicita algún examen complementario? De ser así cuáles?

Inicialmente habría que pedir una placa simple comparativa de ambas caderas para descartar alguna afección ósea. Una ecografía mostraría la presencia de un derrame articular pequeño y engrosamiento sinovial menor a 5 mm, con el resto del estudio normal. Si no se cuenta con ecografía, el laboratorio puede ayudar puesto que en la STC es totalmente normal, no muestra leucocitosis ni aumento de reactantes de fase aguda.

2. ¿Qué conducta tomaría?

Indicar reposo, prescripción de AINES, seguimiento ambulatorio con pautas de alarma.

Responda las siguientes consignas

1. Describa la diferencia entre artralgia y artritis

La artritis se define como la presencia de inflamación de una articulación manifestada por tumefacción, dolor a la palpación o a la movilización y/o limitación de la movilidad.

Mientras que la artralgia presenta sólo dolor, sin tumefacción ni limitación del movimiento.

2. Describa la clasificación de las artritis según tiempo de evolución y número de articulaciones afectadas.

Se clasifican en agudas y crónicas según tengan una evolución menor o mayor a 6 semanas.

A su vez podemos hablar de monoartritis cuando hay inflamación de una sola articulación, oligoartritis hasta un máximo de 4 articulaciones y hablamos de poliartritis cuando son 5 o más las articulaciones afectadas.

3. Enumere las características del líquido articular inflamatorio y séptico extraídos por artrocentesis

Líquido inflamatorio: es de aspecto turbio, de color amarillo opalescente, con leucocitos que van entre 2000 y 100.000 de los cuales alrededor del 50 % son neutrófilos y el cultivo es negativo.

Líquido séptico: es de aspecto purulento, de color amarillo verdoso, más de 100.000 leucocitos donde más del 75 % son neutrófilos y el cultivo es positivo.